

DESCOLAMENTO DE RETINA — URGÊNCIA OFTALMO

TIPOS DE DESCOLAMENTO DE RETINA

Tipo	Mecanismo	Associação
Regmatogênico (mais comum)	Rotura/buraco na retina → líquido sub-retiniano	Miopia alta, trauma, afacia, idade, degeneração
Tracional	Tração de membranas fibrovasculares sobre a retina	Retinopatia diabética proliferativa, retinopatia da prematuridade
Exsudativo (seroso)	Acúmulo de líquido sub-retiniano sem rotura	Tumores, inflamação, HAS maligna, pré-eclâmpsia

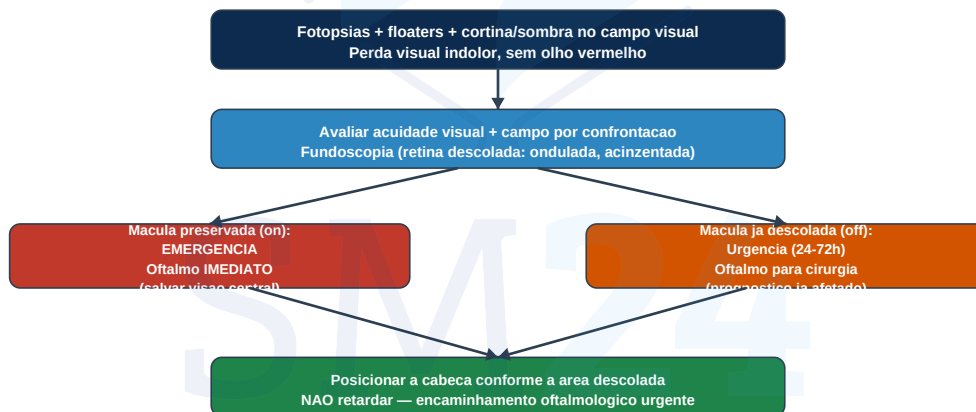
SINTOMAS — RECONHECER PARA ENCAMINHAR

TRÍADE CLÁSSICA DO DESCOLAMENTO REGMATOGÊNICO

- FOTOPSIAS (flashes de luz): tração vítrea sobre a retina — sintoma precoce
- MOSCAS VOLANTES (floaters) novas e em grande quantidade: sangue/pigmento no vítreo
- SOMBRA / CORTINA escura no campo visual: progressão do descolamento (perda de campo)
- Perda visual: indolor; central se mácula acometida (mau prognóstico visual)
- Sem dor, sem olho vermelho — diferencia de causas inflamatórias/glaucoma
- Mácula 'on' (não acometida): emergência — preservar a visão central com cirurgia rápida

ABORDAGEM NO PS

DESCOLAMENTO — RECONHECER + ENCAMINHAR JÁ



TRATAMENTO CIRÚRGICO

Técnica	Indicação	Princípio
Retinopexia pneumática	Descolamento pequeno, superior, rotura única	Injeção de gás intravítreo + posicionamento + laser/crio
Vitrectomia (VVPP)	Descolamentos complexos, tracionais, hemorragia vítrea	Remoção do vítreo + reaplicação da retina + tamponamento
Introflexão escleral (buckle)	Regmatogênico, jovens, roturas periféricas	Faixa de silicone que aproxima a parede do olho à retina
Laser / crioterapia	Roturas/buracos SEM descolamento (profilaxia)	Cria aderência ao redor da rotura — previne descolamento

FATORES DE RISCO E DIFERENCIAL

Fatores de Risco

- Miopia alta (olho mais alongado, retina mais fina)
- Idade (descolamento de vítreo posterior)
- Trauma ocular
- Cirurgia de catarata prévia (afacia/pseudofacia)
- História de descolamento no olho contralateral
- Retinopatia diabética proliferativa (tracional)

Diagnóstico Diferencial da Perda Visual Súbita

- Oclusão de artéria central da retina: perda súbita, indolor, total
- Oclusão de veia central: perda variável, fundo com hemorragias
- Neurite óptica: dor à movimentação, déficit pupilar aferente
- Hemorragia vítrea: floaters, perda variável (DM proliferativa)
- AVC occipital: hemianopsia, sem alteração de fundo de olho
- Glaucoma agudo: dor intensa, olho vermelho, halos (diferente — sintomático)

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Descolamento de retina é urgência/emergência oftalmológica — encaminhar imediatamente
- ☐ Mácula preservada (mácula on) = emergência: cirurgia precoce preserva visão central
- ☐ Fotopsias + floaters novos + cortina = suspeitar e investigar com fundoscopia
- ☐ Perda visual indolor e sem olho vermelho diferencia de causas inflamatórias/glaucoma
- ☐ Não há tratamento clínico — o tratamento é cirúrgico (vitrectomia, buckle, retinopexia)
- ☐ Roturas sem descolamento podem ser tratadas com laser/crioterapia (profilaxia)

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente míope de 55 anos com flashes de luz, aumento súbito de moscas volantes e sensação de cortina escura ascendente no olho direito, indolor. Qual é a principal hipótese?

- A) Glaucoma agudo de ângulo fechado
- B) Descolamento de retina regmatogênico
- C) Neurite óptica
- D) Conjuntivite viral
- E) Catarata madura

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Em um descolamento de retina, qual condição configura EMERGÊNCIA com necessidade de cirurgia o mais rápido possível?

- A) Mácula já descolada (mácula off)
- B) Mácula ainda preservada (mácula on) — cirurgia precoce preserva a visão central
- C) Descolamento exsudativo por hipertensão
- D) Rotura sem descolamento
- E) Floaters isolados sem perda de campo

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é o tipo mais comum de descolamento de retina?

- A) Tracional
- B) Exsudativo (seroso)
- C) Regmatogênico (por rotura/buraco retiniano)
- D) Misto
- E) Por tumor intraocular

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual achado clínico ajuda a diferenciar o descolamento de retina do glaucoma agudo?

- A) O descolamento causa dor ocular intensa
- B) O descolamento é indolor e sem olho vermelho, enquanto o glaucoma agudo cursa com dor intensa, olho vermelho e halos
- C) Ambos causam olho vermelho e dor
- D) O glaucoma cursa com fotopsias e floaters
- E) O descolamento cursa com pupila em midríase fixa dolorosa

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual é o tratamento de uma rotura retiniana SEM descolamento associado (achado isolado)?

- A) Vitrectomia de urgência
- B) Introflexão escleral
- C) Laser (fotocoagulação) ou crioterapia ao redor da rotura — profilaxia do descolamento
- D) Apenas observação sem intervenção
- E) Injeção de gás intravítreo

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Tríade clássica do descolamento regmatogênico: fotopsias (flashes) + floaters novos + cortina/sombra progressiva no campo visual, indolor, em míope. Diferente do glaucoma agudo (dor, olho vermelho, halos). Urgência oftalmológica — fundoscopia e encaminhamento imediato.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Mácula ainda preservada (mácula on) = EMERGÊNCIA: a cirurgia precoce (antes do descolamento atingir a mácula) preserva a visão central. Quando a mácula já está descolada (off), o prognóstico visual já está comprometido e a cirurgia passa a ser urgência (24-72h).

QUESTÃO 3 → Resposta: C

O descolamento regmatogênico é o mais comum — causado por rotura/buraco na retina que permite a passagem de líquido para o espaço sub-retiniano. Associado a miopia, idade (descolamento de vítreo posterior), trauma e cirurgia de catarata prévia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Descolamento de retina é INDOLOR e sem olho vermelho (perda de campo/cortina, fotopsias, floaters). O glaucoma agudo de ângulo fechado cursa com dor ocular intensa, olho vermelho, halos ao redor das luzes, náuseas e midríase média fixa. Distinção clínica importante.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Rotura/buraco retiniano SEM descolamento é tratado com laser (fotocoagulação) ou crioterapia ao redor da lesão — cria aderência que sela a rotura e previne a progressão para descolamento. Quando já há descolamento, o tratamento é cirúrgico (vitrectomia, buckle, retinopexia pneumática).

SM24
Suporte ao Plantão Médico